

La Famiglia — Sintesi

I Tempi della Vita · Sessione 05

La famiglia non è più una sola cosa. È un ecosistema in trasformazione — e tu, come assistente sociale, ti troverai dentro ogni sua variante.

Definizioni di famiglia

- Nessuna definizione universale: i sociologi parlano oggi di **"famiglie"** al plurale
 - Lévi-Strauss: tre pilastri classici — proibizione dell'incesto, unione riconosciuta, divisione sessuale dei compiti
 - **Scabini & Cigoli**: la famiglia lega generi, generazioni e stirpi — ha la **generatività** come progetto centrale
 - **Delvecchio**: sistema complesso, non riducibile alla somma dei suoi membri
 - **Fruggeri**: non più istituzione, ma **unione di affetti**
 - Tipologie: nucleare, monoparentale, ricomposta, omo-genitoriale, adottiva, d'affido, procreazione assistita, LAT, DINKS, unipersonale
-

Genitorialità: sguardo antropologico

- **Esther Goody (1999)**: cinque funzioni della genitorialità — concepire, nutrire, educare, dare identità, garantire l'accesso all'età adulta
 - Nelle nostre società, queste funzioni sono concentrate su padre e madre biologici; in altre culture, distribuite su più adulti
 - **Dissociazione contemporanea**: genitorialità biologica / istituzionale (giuridica) / domestica (cura quotidiana)
 - Il sistema occidentale ancora dominato da: **bilateralità, ideologia del sangue, esclusività**
-

Evoluzione storica

- **Tradizionale (XVI–XVIII sec.):** padre-padrone, donna e figli sottomessi, matrimonio = alleanza tra famiglie
 - **Moderna (fine XVIII – XX sec.):** padre affettuoso, bambino al centro; ma il codice napoleonico (1803) ristabilisce la potenza paterna
 - **Contemporanea (dal 1965):** crollo del modello patriarcale, valorizzazione dell'individuo, coniugalità "privatizzata", aumento divorzi
-

Cambiamenti culturali nella transizione alla genitorialità

(Scabini & Cigoli, 2000)

1. **Si diventa genitori più tardi**
 2. **Avere figli è più raro** → seconda transizione demografica (calo fecondità)
 3. **Avere figli è una scelta** → dalla nascita come evento atteso alla nascita pianificata; il figlio come centro della realizzazione personale; dalla famiglia **etica** a quella **affettiva**
 4. **Aspettative paritarie** → le donne si aspettano un impegno condiviso del partner
-

Il processo di accesso alla genitorialità

(Nanzer & Palacio Espasa)

- Nel **periodo perinatale** (concepimento – 2 anni post-parto), il genitore compie un intenso lavoro psichico
- La donna attraversa la "**trasparenza psichica**": extreme sensibilità, riemersione del passato
- Il genitore rivisita la propria infanzia e le proprie imago genitoriali
- Diventare genitore richiede **lutti di sviluppo**: rinunciare a immagini idealizzate di sé bambino e dei propri genitori

- Se i lutti sono elaborati → la genitorialità è crescita; se non lo sono → il bambino viene usato inconsciamente per "riparare" il passato

I quattro conflitti della genitorialità

Tipo	Meccanismo	Impatto sul bambino
Normale	Identificazioni proiettive flessibili, bidirezionali, positive	Sviluppo sano
Nevrotica	Il bambino è il "bambino ideale" che il genitore avrebbe voluto essere	Disturbi di separazione, sonno, alimentazione
Masochistica	Il genitore si sottomette al bambino per espiare colpe del passato	Disturbi comportamentali, ansia
Narcisistica	Proiezioni rigide e deformanti; diniego e scissione; pre-transfert negativo	Disturbi gravi dell'attaccamento, disturbi della personalità

I casi clinici

Myriam — "L'erede psicologica"

- Bambina adottata (11 anni), triste, difficoltà scolastiche gravi
- La madre aveva scelto l'adozione per sfuggire alla depressione ereditaria della propria famiglia — ma proietta su Myriam l'immagine della propria madre depressa
- Myriam si identifica con la depressione materna per mantenere il legame con la madre
- **Esito:** la madre si riappropria della propria depressione; Myriam migliora e si autonomizza

Régine — "Il sorriso di sollievo"

- Bambina di 9 anni con grave angoscia da separazione
 - La madre (orfana di entrambi i genitori) proietta su Régine l'immagine della buona madre protettiva che lei non ha avuto
 - Régine porta il lutto della madre: non la lascia mai per non farla sentire abbandonata
 - **Esito:** un unico intervento terapeutico dissolve il sintomo; Régine, sollevata, organizza subito un soggiorno dalla cugina
-

Plurigenitorialità e spazio psichico del bambino

- I cambiamenti familiari bruschi mettono a rischio la **continuità narcisistica** del bambino
 - Fondamentale: **mettere in parole** quello che succede, ammettere la **bilinearità delle origini**
 - Rispettare lo spazio psichico = spiegare in modo misurato, accettare i sentimenti del bambino, dargli il diritto al segreto, aiutarlo a conservare i ricordi degli assenti
-

Da ricordare: - **Genitorialità** = processo psichico, non solo biologico; inizia nell'infanzia e si intensifica nel periodo perinatale - **Quattro livelli di conflitto** (normale, nevrotico, masochistico, narcisistico) — determinati dal grado di elaborazione dei lutti del genitore - **I casi Myriam e Régine** mostrano come il sintomo del bambino sia spesso il portavoce del conflitto irrisolto del genitore